

FRÜHWARNUNG FÜR DIE VERSORGUNGSPLANUNG

Dem Engpass eine Woche voraus.

Aeris prognostiziert die regionale Intensivbelegung 1–3 Wochen im Voraus — aus öffentlich verfügbaren Signalen. Damit Kliniken und Gesundheitsämter Personal, elektive Eingriffe und Verlegungen planen, statt auf die Krise zu reagieren.

KURZKONZEPT FÜR KLINIKEN & ÄRZTLICHE PARTNER

16

Bundesländer, live

1–3 Wo.

Vorlaufzeit

5

öffentliche Frühindikatoren

DAS PROBLEM

Das Gesundheitssystem reagiert zu spät

Kliniken und Gesundheitsämter entscheiden täglich unter Unsicherheit: Wie viele Intensivpflegekräfte planen wir für nächste Woche? Verschieben wir elektive Eingriffe? Steuert die Region auf einen Kapazitätsengpass zu? Diese Entscheidungen fallen heute **reaktiv** — auf Basis der aktuellen Belegung. Dabei entwickeln sich viele Treiber der Nachfrage — Atemwegsinfekte, saisonale Wellen, Wetter — **Tage bis Wochen im Voraus**.

Konkret heute (18. Juli 2026): Die mittlere Intensivbelegung liegt bundesweit bei **83 %** der *betreibbaren* Betten, in **4 von 16** Ländern bereits über der kritischen Schwelle von 85 %. Der Engpass ist kein Ausnahmezustand mehr, sondern Dauerzustand — und er wird primär vom **verfügbaren Personal** bestimmt, nicht von der Bettenzahl.

UNSERE LÖSUNG

Eine Vorausschau-Schicht für die Versorgung

Aeris kombiniert öffentlich verfügbare Signale zu einer belastbaren Prognose der regionalen ITS-Belegung — mit Unsicherheitsband und einer Wahrscheinlichkeit, die kritische Kapazität zu überschreiten. Der Kausalpfad respiratorisch getriebener Nachfrage ist gut verstanden:

Viruszirkulation → Erkrankung in der Bevölkerung → Arztbesuch / Hospitalisierung → **ITS-Aufnahme**

01**Zusammenführen**

Alle Quellen werden auf die Bundesland-Ebene ausgerichtet — die Auflösung, in der die DIVI-Grundwahrheit aktuell verlässlich vorliegt.

02**Modellieren**

Ein Zeitreihenmodell verknüpft die autoregressive Belegung mit den Vorlaufsignalen entlang des Kausalpfads.

03**Quantifizieren**

Jede Prognose kommt mit Unsicherheitsband und Überschreitungswahrscheinlichkeit — nicht nur ein Punktwert.

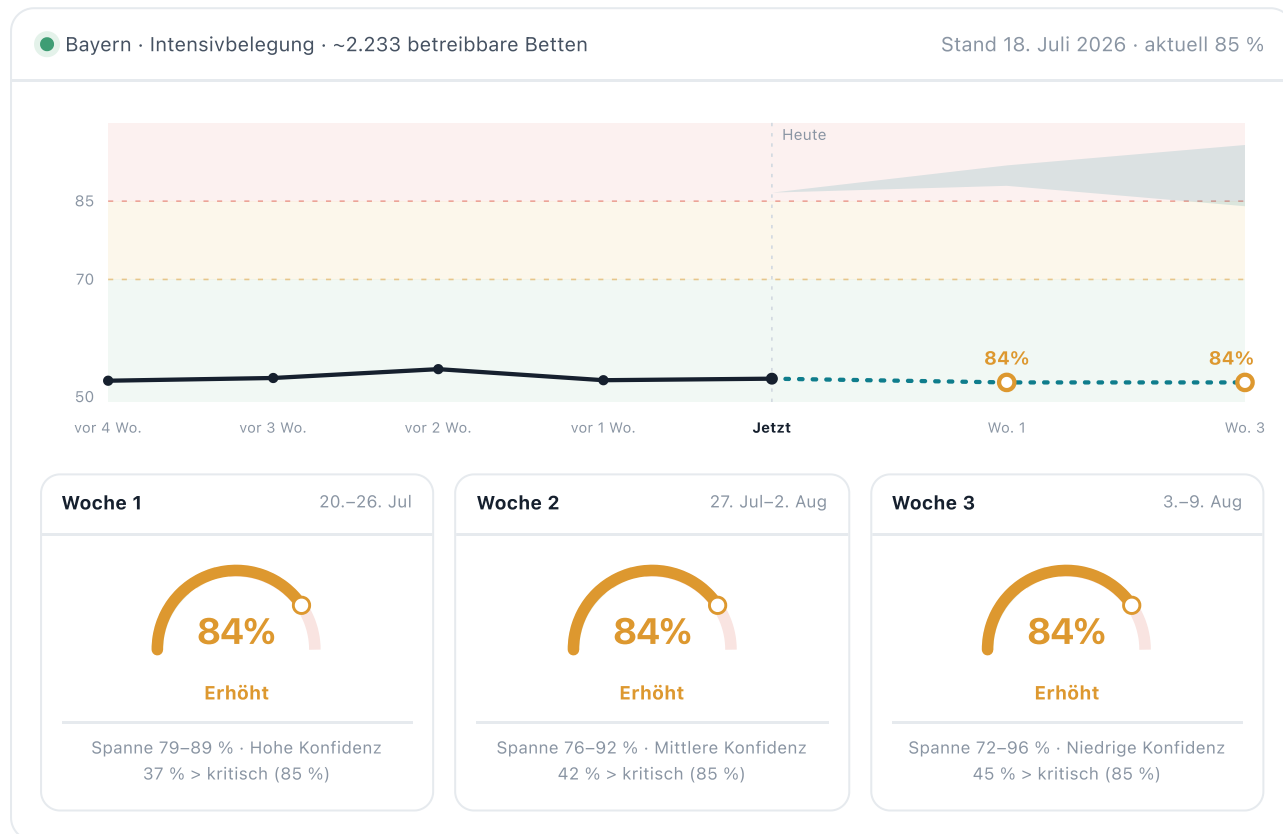
04**Handeln**

Personalplanung, elektive Eingriffe, Verlegungen — Entscheidungen mit Vorlauf statt in der Krise.

DAS PRODUKT · BEISPIEL BAYERN

Regionale ITS-Belegung, 3 Wochen voraus

So sieht eine Prognose aus — hier für Bayern, mit echten Daten vom 18. Juli 2026. Die aktuelle Belegung von **85 %** dürfte sich auf hohem Niveau halten; das Vorlaufsignal der Hausarzt-Konsultationen (ARE) steigt, die SARI-Hospitalisierungen fallen — beides fließt in die Prognose ein.



DATENGRUNDLAGE

Öffentlich, gepflegt, skalierbar

SIGNAL	QUELLE	VORLAUF	STATUS
ITS-Belegung (Grundwahrheit)	DIVI-Intensivregister · RKI	0 (Ziel)	LIVE · TÄGLICH
SARI-Hospitalisierung	RKI · ICOSARI	3–7 Tage	LIVE · WÖCHENTL.
ARE-Konsultationen	RKI · AGI-Sentinel	1–2 Wochen	LIVE · WÖCHENTL.
Temperatur	DWD · Open Data	1–2 Wochen	LIVE · TÄGLICH
Feiertage & Schulferien	openholidaysapi.org	im Voraus	LIVE · STATISCH
Abwasser-Monitoring	Umweltbundesamt · AMELAG	1–2 Wochen	GEPLANT · V1.1

DER NUTZEN FÜR IHR HAUS

Was ein Vorlauf von 1–3 Wochen ermöglicht

Personalplanung

Intensivpflege-Dienstpläne früher und ruhiger disponieren — statt kurzfristiger Ausfälle und teurer Leasingkräfte im Engpass.

Elektive Eingriffe

OP-Programme vorausschauend steuern: verschieben, wenn ein Anstieg droht — durchziehen, wenn Spielraum bleibt.

Verlegungen & Reserve

Surge-Betten und regionale Verlegungen früh koordinieren, bevor die Belegung die kritische Schwelle erreicht.

Regionale Koordination

Gesundheitsämter sehen, welche Region als Nächstes unter Druck gerät — und können Kapazitäten vorausschauend ausgleichen.

„Intensivbelegung in der Region München erreicht in zwei Wochen voraussichtlich 88 % — mit 40 % Wahrscheinlichkeit, die kritische Kapazität zu überschreiten.“

Beispielhafte Kernaussage — die Art von Frühwarnung, die heute fehlt.

STAND & FAHRPLAN

Vom Prototyp zum validierten Frühwarnsystem

Heute

Live-Prototyp, state-level

Lauffähiges Dashboard für alle 16 Bundesländer auf echten öffentlichen Daten, mit transparenter Persistenz-Basislinie plus Signal-Tilt.

Nächste

Validiertes Modell

Trainiertes Zeitreihenmodell je Land auf 2020–2025-Historie, evaluiert gegen die naive Basislinie — mit ausgewiesener Prognosegüte je Horizont.

v1.1

Regionale Tiefe & Abwasser

Feinere Regionen (z. B. Allgäu, historisch verfügbar) über Datenpartnerschaft; Abwasser-Signal (AMELAG) als stärkste Erweiterung.

Pilot

Klinik-Pilot

Ein Partnerhaus integriert die Prognose in die Wochenplanung — mit Feedback-Schleife zur Kalibrierung an der Realität vor Ort.

Gesucht: ein klinischer Partner für den Pilot

Wir suchen Häuser und ärztliche Partner, die die Prognose in der Praxis erproben — und uns helfen, sie an echten Planungsentscheidungen zu schärfen.

LIVE-DEMO

nicolaslekai.github.io/aeris

KONTAKT

nicolaslekai@gmail.com

EBENE HEUTE

Bundesland · 16 Regionen

Alle Belegungswerte beziehen sich auf betreibbare (personell verfügbare) Intensivbetten. Prognosewerte stammen aus einer transparenten Basislinie plus Vorlaufsignal-Tilt und sind noch nicht durch ein trainiertes Modell validiert. Datenquellen: DIVI-Intensivregister, RKI (ICOSARI, AGI), DWD, openholidaysapi.org — alle öffentlich verfügbar. Stand 18. Juli 2026.